Kongressbericht: 51. Deutscher Koloproktologen-Kongress

München, 13.–15. März 2025

Felix Aigner[1] · Oliver Schwandner[2]

[1] Graz, Österreich
[2] Regensburg, Deutschland

Veränderung bedeutet nicht immer Verbesserung, aber um zu verbessern, muss man sich verändern. – Winston Churchill

Diesem Motto folgend, haben wir uns nach gewissenhafter Prüfung sämtlicher Möglichkeiten gemäß den Bedürfnissen unserer Gesellschaft in den letzten Jahren für den Kongress am Park in Augsburg als neuen Veranstaltungsort des Deutschen Koloproktologen-Kongresses entschieden. Man könnte meinen, wir sind gekommen, um zu bleiben! Dies sei vorweggenommen, der Umzug innerhalb Bayerns trotz Sprachspezifika, wie sie unser Generalsekretär Prof. Oliver Schwandner in seiner Begrüßungsansprache am Kongressfreitag so treffend erwähnt hat, ist auf breite Zustimmung von Seiten der Kongressteilnehmer und der Industriepartner gestoßen. Knapp 1100 Teilnehmer (davon ca. 200 online) sind der Einladung zum 51. Deutschen Koloproktologen-Kongress nach Augsburg gefolgt, um sich zu den Hauptthemen „Stuhlinkontinenz", „Aktuelle Therapiekonzepte bei CED, Pouchitis und Fistelleiden", „Kolorektales Karzinom – was bringt die neue Leitlinie?" und „Anale Dysplasien" fortzubilden.

Der Deutsche Koloproktologen-Kongress ist und bleibt damit die größte deutschsprachige wissenschaftliche Versammlung, die sich rein dem Thema „Koloproktologie" seit Beginn an widmet, welcher auf das Jahr 1974 in Kronberg im Taunus nahe Frankfurt am Main zurückgeht.



© Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie

▲ Voller Vortragssaal in der Eröffnungssitzung

coloproctology 2025 · 47:238–241
https://doi.org/10.1007/s00053-025-00888-z
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e. V. (BCD)
Prof. Dr. Dieter Bussen (V. i. S. d. P.)
Deutsches End- und Dickdarm-Zentrum Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim
E-Mail: info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie (DGK)
Prof. Dr. Oliver Schwandner (V. i. S. d. P.)
Krankenhaus Barmherzige Brüder
Abteilung für Proktologie
Prüfeninger Straße 86
93049 Regensburg
E-Mail: info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Das Programm des diesjährigen Kongresses wurde von der DGK als wissenschaftliche Fachgesellschaft durch den Generalsekretär (Prof. O. Schwandner, Regensburg) und den Kongresspräsidenten (Prof. Dr. Thomas Seufferlein, Ulm) in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands (BCD) und der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Coloproktologie (CACP) der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) konzipiert, organisiert und durchgeführt.

Der Donnerstag vor dem eigentlichen Kongress stand traditionell ganz im Zeichen von insgesamt 9 Seminaren, einem Pflegesymposium „Rund ums Stoma und Wundmanagement" sowie Irrigationsworkshop und drei Satellitensymposien zu den Themen „Neue Horizonte in der Koloproktologie" mit der Vorstellung künstlicher Intelligenz in der Koloproktologie, Präventionsstrategien bei analen intraepithelialen Neoplasien und berufspolitischen Themen wie Personalmangel, Kostendruck und Ambulantisierung. Am Freitag fand traditionell das MFA-Seminar statt.

Das wissenschaftliche Hauptprogramm des Jahreskongresses wurde durch vier Hauptthemen, freie Vorträge und die Preisträgersitzungen repräsentiert:

Das **Thema *Stuhlinkontinenz*** wurde in der Eröffnungssitzung am Freitagvormittag ausführlich behandelt. Wahrscheinlich einer der Höhepunkte des ganzen Kongresses galt unumstritten der wie immer lebhaften und bildlichen Präsentation über die Anatomie des Kontinenzapparates durch unseren Haus-und-Hof Anatomen Prof. Thilo Wedel aus Kiel, der uns das Wesen des Beckenboden Quintettes in konzertanter Art und Weise nähergebracht hat. Wer wenn nicht er könnte uns kunstliebenden Proktologen den Levator ani als Horn, den äusseren Schließmuskel als Fagott, den inneren Schließmuskel und M. longitudinalis ani als erste und zweite Oboe, das Corpus cavernosum recti – oder besser Plexus anginosus – als Klarinette und die anorektale Sensibilität als Flöte besser näherbringen. Untermalt mit eindrucksvollen anatomischen Prä-

paraten schaffte „Maestro Wedel" einen wahren Kunstgenuss als gelungene Ouvertüre.

Das Auditorium diskutierte im Saal und über den online Chat rege mit den Referenten über Diagnostik, dem fragwürdigen Stellenwert der analen Manometrie, konservative und chirurgische Therapie der Stuhlinkontinenz auch im Kontext organüberschreitender Beckenbodenfunktionsstörungen.

Neben freien Vortragssitzungen – mit einem hochinteressanten Angebot an neuen und innovativen Themen der Koloproktologie – wurde am Freitagnachmittag in der **Special lecture** „Skills lab 2.0: The future of teaching in robotic colorectal surgery" von Marcos Gómez-Ruiz aus Santander (ESP) das ColoRobotica Projekt der European Society of Coloproctology (ESCP) vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein auditfähiges und standardisiertes Trainingsprogramm für robotisch-assistierte kolorektale Eingriffe, das von speziell ausgebildeten Trainern (Proctoren) in einem Curriculum unter der Schirmherrschaft der ESCP ausgetragen wird. Die DGK hat per Vorstandsbeschluss an der Präsidiumssitzung am Donnerstag einer Kooperation mit der ESCP (Colorobotica) dahingehend zugestimmt. Somit haben wir die einzigartige Möglichkeit unter der Federführung der DGK ein standardisiertes robotisches Trainingsprogramm für kolorektale Chirurgie in Deutschland flächendeckend anzubieten.

In der **Preisträgersitzung** wurde u. a. die Verbesserung der Aussage des prätherapeutischen MRT-Stagings beim Rektumkarzinom durch Schulung und Software-Unterstützung (Sigmar Stelzner, Leipzig) diskutiert. Weitere Themen waren Notfallresektionen beim kolorektalen Karzinom mit einem klaren Plädoyer für das Notfallsstoma zum anschließenden ungetrübten Staging der Tumore (Julius Plewe, Charité Berlin) sowie das Management des „early-onset" kolorektalen Karzinoms in der Schwangerschaft (Florian Scholz, LMU München) und das Aufgreifen des Vorjahresthemas der PROMs (patient related outcome measures) beim ileocoecalen Crohn (Carolina Mann, Mainz). Preisträger in diesem Jahr war Skander Bouassida aus Berlin (Humboldt Klinikum) mit einer eindrucksvollen Präsentation der Möglichkeit des robotischen Vorgehens beim vertikalen rectus abdominis myofaszioperitonealen Lappens (VRAM) zum Beckenbodenersatz nach abdomino-perinealer Rektumamputation.

Den Abschluss des ersten Kongresstages bildete die Hauptsitzung **„Aktuelle Therapiekonzepte bei CED, Pouchitis und Fistelleiden"** unter der Federführung unseres scheidenden Präsidenten Prof. Thomas Seufferlein, der mit Maia Kayal aus dem Mount Sinai in New York eine ausgewiesene Spezialistin zum Thema Pouchitis nach Proktokolektomie gewinnen konnte, die via Videozuschaltung in perfekter Bild- und Tonqualität die mittlerweile mannigfaltigen Therapieansätze bei der bis zu 30 % auftretenden Pouchitis inklusive Antikörpertherapie präsentierte. Den chirurgischen Part dieser äußerst spannenden interdisziplinären Sitzung unseres Präsidenten übernahm in gewohnt übersichtlicher und gut strukturierter Weise Prof. Peter Kienle aus Mannheim, der einmal mehr die Relevanz der Zentrumsbildung gerade bei so hoch-komplexen Eingriffen wie Pouchrevisionen unterstrich.

Nach einem anstrengenden ersten Kongresstag inklusive Mitgliederversammlung mit einstimmigen Entlastungen unseres Vorstandes pilgerten wir zum **DGK-Abend ins Riegele WirtsHaus**, einem Wahrzeichen von Augsburg im bereits 1386 gegründeten Augsburger Brauhaus, koloproktologische Gemütlichkeit und Appetit nach getaner Arbeit kamen nicht zu kurz und wurden durch schwäbische Köstlichkeiten befriedigt.

Der zweite Kongresstag begann mit einer spannenden Sitzung zu dem Thema **„Kolorektales Karzinom – Was bringt die neue Leitlinie?"** und wurde in Zusammenarbeit mit der CACP initiiert. Neben dem Schwerpunkt zielgerichtete, personalisierte Therapieplanung anhand moderner Molekularpathologie und *liquid biopsy* wurden die aktuellen Studien zum Thema neoadjuvante Therapie beim Kolonkarzinom durch unseren Präsidenten Thomas Seufferlein beleuchtet. Es wurden vier Studien präsentiert, die bis auf eine Ausnahme (FOxTROT trial; [1]) keinen signifikanten Vorteil der neoadjuvanten Therapie in Hinblick auf onkologische Langzeitparameter wie Gesamtüberleben oder krankheitsfreies Überleben beim Kolonkarzinom zeigten. Großes Problem nach wie vor beim Kolonkarzinom ist eine nicht zu vernachlässigende Rate an Overstaging (25–33 %) in der routinemäßig eingesetzten Computertomografie und demnach einer Übertherapie in manchen Studien.

Außerdem wurden chirurgische Strategien beim Kolonkarzinom mit dem vieldiskutierten Thema der kompletten mesokolischen Exzision (CME) mit der Frage nach einem Standard und einer klaren Empfehlung für die CME beim Kolonkarzinom sowohl in der alten als auch in der Konsultationsfassung der neuen S3-Leitlinie dargelegt. Dies trifft vor allem für das UICC Stadium III mit Vorteil im 5-Jahres-Gesamtüberleben in der CME-Gruppe mit zentraler Lymphknotendissektion zu. Umso paradoxer und – unumstritten mit einem Bias versehen – erscheint die chinesische RELARC Studie, die keinen signifikanten Vorteil der CME im 3-Jahres krankheitsfreien und Gesamtüberleben gezeigt hat, jedoch gerade die Patienten mit radiologisch eindeutigem Befall von zentralen (D3) Lymphknoten ausgeschlossen hatte [2]. Ein Plädoyer für eine noch individualisierte Therapieplanung beim Rektumkarzinom in Bezug auf Multimodalität und technischem Zugang (Stichwort robotisch) rundete diese Morgensitzung ab.

Herauszuheben sind auch wieder die Menge und Qualität an freien Vorträgen, die in zwei gut besuchten Sitzungen an beiden Tagen, präsentiert wurden. Hier bleibt hervorzuheben, dass viele jüngere Kolleginnen und Kollegen ihre experimentellen und klinischen Studien vorstellten.

Den Abschluss des wissenschaftlichen Programmes bildete die vom BCD konzipierte Sitzung **„Anale Dysplasien"**. Sie bot ein praktisches „Vademecum" für die Abklärung und Behandlung von HPV-assoziierten Erkrankungen des anogenitalen Bereiches. Im Fokus der Vorträge und lebhaften Diskussionen standen hier Themen wie die korrekte Nomenklatur, die Bedeutung der Impfung, die Pathophysiologie und die histopathologischen Grundlagen. Darüber hinaus wurde über „Pro und Contra" der HR-Anoskopie referiert. Den Abschluss bildeten Vorträge zu konservativ-topischen Therapiemodalitäten und chirurgischen Möglichkeiten bzw. Grenzen bei „Analer Intraepithelialer Neoplasie".

Der diesjährige **Jens J Kirsch-Preis** ging an Dr. Skander Bouassida mit dem Titel:

Der robotische Vertikale Rectus Abdominis Myofaszioperitoneale-Lappen (rVRAM) zum Beckenbodenersatz nach abdominoperineale Rektumamputation (rELAPE): Entwicklung der Technik und Fallserie. *Skander Bouassida (Berlin); Till Lunenburg (Berlin); Jochen-Frederick Hernekamp (Berlin); Ulrich Adam (Berlin)*



© Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie

▲ *v. l. n. r.*: Prof. Thomas Seufferlein, Dr. Skander Bouassida, Prof. Oliver Schwandner



© Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie

▲ *v. l. n. r.* Prof. Thomas Seufferlein, Dr. Katharina Esswein, Prof. Oliver Schwandner



© Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie

▲ *v. l. n. r.* Prof. Thomas Seufferlein, Dr. Susanne Bock, Prof. Oliver Schwandner



© Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie

▲ *v. l. n. r.* Prof. Thomas Seufferlein, Dr. Rebecca Ulbrich, Prof. Oliver Schwandner

Die diesjährigen drei **DGK-Posterpreise** erhielten

1. Posterpreis:
   Integration der Mikroskop-gestützten Anoskopie (High Resolution Anoscopy, HRA) in die Nachsorgekontrollen nach Analkarzinom (AK) kann das Rezidivrisiko senken*Susanne Bock (St. Gallen); Joel Dütschler (St. Gallen); Moritz Sparn (St. Gallen); Lukas Marti (St. Gallen)*
2. Posterpreis:
   Endoskopische Radiofrequenzablation: Die Lösung für das therapeutische Dilemma der chronischen Strahlenproktitis? *Katharina Esswein (Innsbruck); Marijana Ninkovic (Innsbruck); Veronika Kröpfl (Innsbruck); Elisabeth Gasser (Innsbruck); Christoph Profanter (Innsbruck)*
3. Posterpreis:
   Einfluss der Kono S Anastomose auf das Anastomosen-nahe Morbus Crohn Rezidiv nach Ileocoecalresektion. *Rebecca Ulbrich (München); Maximilian Sohn (München); Franz Bader (München)*

Der Transfer des Deutschen Koloproktologen-Kongresses von München nach Augsburg darf demnach als sehr erfolgreich und zukunftsreich angesehen werden. Die konstanten Teilnehmerzahlen an den wissenschaftlichen Sitzungen und Seminaren sowie die Treue der Industriepartner unserem jährlichen Treffen gegenüber in politisch und wirtschaftlich unsteten Zeiten bestätigten uns, auch 2026 vom 12.–14. März nach Augsburg zurückzukehren und die Tradition von wissenschaftlicher Aus-und Fortbildung in kompakter Form, Wissensvermittlung in wissenschaftlichen Sitzungen ohne Parallelveranstaltungen (sic!) und praktisch orientierten Kursen bzw. Seminaren, jede Menge Zeit zum Netzwerken und Wiedersehen bekannter Kolleginnen und Kollegen sowie beruflicher Weggefährten zum persönlichen Austausch fortzuführen.

Deshalb blickt die DGK am Ende des 51. Deutschen Koloproktologen-Kongresses in Augsburg dankbar auf erfolgreiche Kongresstage in Augsburg zurück – und hofft, dass die „koloproktologische Familie“ auch vom 12.–14.03.2026 wieder in Augsburg zusammenkommt.

Ausblick auf den nächsten **Deutschen Koloproktologen-Kongress:**



Literatur

1. Morton D, Seymour M, Magill L, Handley K, Glasbey J, Glimelius B, Palmer A, Seligmann J, Laurberg S, Murakami K, West N, Quirke P, Gray R (2023) FOxTROT Collaborative Group. Preoperative Chemotherapy for Operable Colon Cancer: Mature Results of an International Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol 41(8):1541–1552
2. Lu J, Xing J, Zang L, Zhang C, Xu L, Zhang G, He Z, Sun Y, Feng Y, Du X, Hu S, Chi P, Huang Y, Wang Z, Zhong M, Wu A, Zhu A, Li F, Xu J, Kang L, Suo J, Deng H, Ye Y, Ding K, Xu T, Zhang Y, Zhang Z, Zheng M, Su X, Xiao Y (2024) RELARC study group. Extent of Lymphadenectomy for Surgical Management of Right-Sided Colon Cancer: The Randomized Phase III RELARC Trial. J Clin Oncol 42(33):3957–3966